

国健医疗

四诊合参体质辨识报告

开封市龙亭区 1234452345

患者信息：

姓名：	阿斯蒂芬	性别：	男	年龄：	19岁	生日：	2006-04-13
住址：	萨芬国色天						

四诊初步诊断

望诊（舌象分析）



舌苔图

核心证候为脾虚湿盛兼轻度气阴两虚。舌质淡红偏淡（舌色偏淡指数较高），舌体略胖、边有轻微齿痕，苔薄白润，舌面湿润无燥裂，提示脾失健运、水湿内停；舌尖稍红、舌中根部略显淡，反映中焦气虚兼轻度虚热。建议：①饮食宜温补健脾，如山药、莲子、薏苡仁煮粥；②忌生冷寒凉及油腻甜食，以防助湿伤脾。

闻诊（体质诊断）

诊断结论：气虚质

置信度：94.0%

暂未进行声音分析，请补充闻诊数据。

体质标签：气力不足 声音偏弱

声带振动不规则

问诊（症状问卷）

专项问诊结论

阴虚质、血瘀质

平和质

体质总体协调，阴阳气血较为平衡，日常以维持稳定作息和均衡饮食为主。

饮食建议

- 三餐规律，饮食均衡，不偏食
- 谷物、蔬菜、优质蛋白搭配摄入
- 保持清淡适度，避免长期暴饮暴食

禁忌提醒

- 避免长期熬夜
- 避免过度劳累和久坐不动
- 避免饮食过于油腻或极端节食

后续建议

- 坚持每周适量运动
- 保持情绪平稳，规律作息
- 定期体检，动态观察体质变化

切诊（脉搏检测）

心率：75.5 bpm

血氧：99.5 %

信号有效率：96.6 %

采样数：144

中医建议：

【结论性质】本结果基于PPG自动分析，仅反映当前时段脉搏特征倾向，不等同于临床确诊。【融合判定】数脉倾向（多特征融合）【区分度】主次得分差=0.3（越高表示判定越稳定）【融合得分】数=1.5，迟=0.5，缓=1.2【脉象倾向】数脉倾向（心率偏快）【解释】常见于紧张、运动后、发热等状态，需结合当时场景判读。【脉搏特征】脉象倾向不单一（需结合临床）、数脉倾向、节律不齐倾向、脉势偏弱、证据:心率中段(75.5bpm)、证据:节律波动偏大(CV=0.1878)、证据:HRV偏高(RMSSD=167.862ms, SDNN=99.543ms)【量化摘要】RMSSD=167.862ms, 节律CV=0.1878, 灌注指数PI=0.6206%。【提示】节律波动偏大，建议静息后复测，并结合临床心电评估。

AI 重点分析（望诊）

本段将围绕所选侧重板块展开更详细分析。

好的，作为资深中医四诊合参医生，我将基于您提供的全部数据，遵循“望诊优先”的分析策略，为您呈现一份可信、可执行的中医综合诊断报告。

中医四诊合参诊断报告

患者：阿斯蒂芬（男，19岁）

一、结论摘要

- 核心病机为脾虚湿盛，兼有气阴两虚。**主要证据来自望诊舌象，显示舌质淡红偏淡、舌体胖有齿痕、苔薄白润，此为脾失健运、水湿内停的典型表现；同时舌尖稍红、舌中根部偏淡，提示气虚基础上伴有轻度虚热。
- 气虚体质倾向明确。**闻诊算法结论为“气虚质”，置信度高，特征为“气力不足、声音偏弱”，与望诊所见脾虚（中焦气虚）相互印证。
- 存在阴虚与血瘀的潜在倾向。**问诊问卷算法结论为“阴虚质、血瘀质”，得分均为中度偏颇。此结论与望诊所见“轻度气阴两虚”及切诊提示的“节律波动偏大”有一定关联，但需结合年轻男性、舌象无明显瘀斑、舌质不红绛等特点审慎看待，可能为功能性的失调或亚健康状态。
- 当前生理状态存在功能波动。**切诊显示心率正常但节律波动偏大（CV=0.1878），HRV偏高，提示自主神经功能可能不稳定，常见于思虑、紧张或疲劳状态，与脾虚气虚、心神失养的病机可相关联。
- 调理核心在于健脾祛湿，佐以益气养阴。**所有证据链指向脾胃功能是当前调理的关键，需避免饮食生冷油腻伤脾助湿，同时兼顾养阴活血，调整生活节律。

二、侧重板块深度复核：望诊（舌诊）

1. 关键数据摘录与算法结果解读

- 算法主结论：**“核心证候为脾虚湿盛兼轻度气阴两虚。”
- 舌象结构化指标 (tongueMetrics):**
 - 舌色偏淡指数 (mean: 70): 强度“高”，是本次舌象最突出的特征。
 - 舌色偏红指数 (mean: 30): 强度“中”，提示存在一定的“热”象，但程度不深。
 - 津液亏虚指数 (mean: 15) & 苔色黄腻指数 (mean: 10): 强度“低”，表明目前无明显干燥或湿热内蕴的严重表现。
 - 瘀血征象指数 (mean: 5): 强度“低”，舌面未见典型瘀斑、瘀点。

2. 中医证候推理与证据链分析

- 脾虚湿盛的核心证据:**
 - 舌质淡白:** 舌色偏淡指数70 直接对应“舌质淡红偏淡”。淡白舌主气血两虚、阳气虚弱。结合患者为青年男性，首先考虑**脾气虚**，气血生化不足，不能上荣于舌。
 - 舌体胖大、边有齿痕:** 算法结论中明确指出。脾主运化水湿，脾气虚弱，运化失职，则水湿内停，浸渍舌体，导致舌体胖大受牙齿挤压而形成齿痕。这是“湿盛”的直观表现。
 - 苔薄白润:** 白苔主表证、寒证、湿证；润苔提示津液未伤，水湿内停。此苔象符合脾虚生湿，而非热邪或燥邪为患。
 - 关联推理:** 脾虚则气血生化乏源，导致**气虚**；湿性重浊粘滞，阻碍气机，可进一步加重气虚。这与闻诊的“气虚质”结论高度一致。
- 兼夹气阴两虚的佐证:**
 - 舌尖稍红:** 算法结论提及。舌尖属心肺。心火偏亢或阴虚火旺均可致舌尖红。结合整体舌淡、苔白润，可排除实火，考虑为**气虚及阴**，导致心阴相对不足，虚火上炎。
 - 舌中根部显淡:** 舌中部属脾胃，根部属肾。中根部淡白进一步强化了**中焦（脾胃）气虚**的判断，肾气亦有不足之象。
 - 与问诊的关联:** 问诊提示“阴虚质”，可与此处“轻度气阴两虚”相互参照。脾为后天之本，气血生化之源，长期脾虚可导致阴血生成不足，形成气阴两虚之证。

3. 风险提示

- 当前湿象尚不严重（苔不腻），但若饮食不节（嗜食生冷、甜腻），极易加重湿浊，可能转化为**苔白腻或黄腻**，出现脘腹胀满、大便粘滞等症。
- 气阴两虚若持续发展，尤其在熬夜、思虑过度情况下，阴虚火旺可能更明显，出现口干、心烦、失眠等症。

4. 望诊针对性调护建议

- 饮食：**严格忌口生冷（如冰饮、凉拌菜）、油腻、甜食（如糕点、含糖饮料）。主食可多吃小米、薏苡仁、山药、莲子粥，以健脾祛湿。
- 起居：**避免久坐久卧，以防气机壅滞助湿。注意保暖，尤其腹部，避免外寒直中脾胃。

三、 其余板块复核

1. 闻诊（音频）

- 核心发现：**算法结论为“气虚质”，置信度高（0.94）。特征标签“气力不足、声音偏弱”是气虚的典型闻诊表现，与望诊脾虚气虚病机完全吻合。
- 简要建议：**日常避免长时间、高声调说话，耗伤肺气。可练习匀、细、深、长的腹式呼吸，以培补气机。

2. 问诊（问卷）

- 核心发现：**算法结论为“阴虚质、血瘀质”，两者得分并列（15分，中度偏颇）。此结论提示了除脾虚湿盛外，还存在阴液不足与血行不畅的倾向。
- 简要建议：**需审视是否有熬夜、用眼过度、思虑过重等耗伤阴血的行为。饮食可适当添加银耳、百合、黑芝麻等平和滋阴之品，避免辛辣温燥。适度活动以促进气血流通。

3. 切诊（脉诊）

- 核心发现：**生理指标（心率、血氧）正常，采集质量高。算法提示“数脉倾向”、“节律波动偏大”、“脉势偏弱”。HRV偏高（RMSSD=167.862ms）在青年人中可见，但结合节律CV值偏大，提示**心神不宁、气血运行略有紊乱**，可能与学习压力、思虑伤脾耗气有关。
- 简要建议：**算法已提示“建议静息后复测”。日常应保证充足睡眠，避免紧张、焦虑情绪，可通过冥想、散步等方式舒缓心神。

四、 体质判断与证型结论

- 体质判断：**气虚体质为当前主要体质倾向（依据：闻诊conclusion，望诊result及tongueMetrics）。阴虚质与血瘀质为潜在或兼夹体质倾向（依据：问诊conclusion及scores）。
- 证型结论：**脾虚湿蕴证（主证），兼夹气阴两虚证。
- 诊断依据：**
 - 脾虚湿蕴：**核心依据来自望诊。舌色偏淡指数70及result中“舌质淡红偏淡、舌体略胖有齿痕、苔薄白润”构成直接证据链。
 - 气虚：**望诊（舌淡）与闻诊（conclusion: 气虚质, tags: 气力不足）交叉验证。
 - 阴虚倾向：**望诊（result: 舌尖稍红、轻度气阴两虚）与问诊（conclusion: 阴虚质）共同提示。
 - 功能状态波动：**切诊tcmSuggestion中“节律波动偏大”、“脉势偏弱”为佐证，反映气血不和的状态。

五、 个性化调理方案

总原则：健脾祛湿为主，益气养阴为辅，佐以安神活血。

1. 饮食调理：

- 宜食：**粳米、小米、山药、南瓜、莲子、薏苡仁、白扁豆、鲫鱼。可常用山药薏米莲子粥。
- 慎食：**冰淇淋、冷饮、肥肉、油炸食品、甜点、糯米制品（

报告生成时间：2026/4/12 16:23:17

本系统仅为中医诊断辅助工具，不具备医疗资质，输出结果仅供参考，不能替代专业中医师面诊及诊疗方案

签发医师：张翰

3个月

